

ACOMPANHAMENTO ☒ CONSULTA
NS

ANDRE LUIZ ROSA MAYORAL

IDADE: 62	PESO: 83	ALTURA: 185	PROFISSÃO: Engenheiro
SINTOMAS:			
QUEIXAS: Indisposição / Memória ↓ / Atenção			
MEDICAMENTOS: Vitaminas			
mega HAS / DM			
MÉDICO: Dr. William / Dra Keyft.			
MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N			
EXERCÍCIO FÍSICO: Caminhada todos os dias (3x 4x musculação)			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇOS LANCHE: S JANTAR: S (20h)			
HORA QUE DORME: 00:00		HORA QUE ACORDA: 7h	
COCHILHO ☒ SIM () NÃO às vezes		DORME ACOMPANHADO ☒ SIM () NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM ☒ X NA SEMANA () NÃO ^(2x) (Bebe a esposa)			
FUMO () SIM () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: mista		BANHEIRO: 1x 2x	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: não	MALLAMPATI: IV	IAH: 66,2	SPO2: 66%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: N		/ AO: 34.7 e fev média	
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA		/ AC: 22.8 e fev	
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:		/ FH: 31.5 e fev	
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA			
(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS Dor lombar.			
24/04/24 P = automática max. N30i			
26/06/24 P = 7.6 cmH ₂ O			
IAH = 4.1			
m. de uso: 7h			
bem adaptado fua			
11/07/24 P = 7.7 cmH ₂ O - Dor na perna (E).			
IAH = 2.6 e fev			
m. de uso: 7h20' fua			
19/08/24 P = 7.7 cmH ₂ O			
IAH = 2.5 e fev			
m. de uso:			
13/11/24 P = 8.6 cmH ₂ O			
IAH = 1.2 e fev			
m. de uso: 7h30' Rampa 0.			
Relata estar roncando ↑ P = 9.0 - fua			
Obs Deixei o CPAP fixo "elite"			
P fixa 8 / EPR = 1 fua			
22/01/25 atendimento On line			
e na compra na internet fua			

DR. ALBERTO REMESAR

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

DR. ELITÂNIA MARINHO PONTES

CRM-SP: 62.858

CRM-SP: 69.730

PSIQUIATRIA

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: André Luiz Rosa Mayoral

EXAME nº: 5262

SOLICITADO POR: Dra. Marta Solange Rampani

DATA: 14/11/2022

IDADE: 62 anos

(Esse foi o
exame
horrorível.
Péssimas
condições de
local e
aparelho)

Comentários:

Exame iniciado às 23h31min e concluído às 06h47min. A latência para o sono foi de 13 minutos e a latência para o estágio REM, de 124 minutos. O tempo total de sono foi de 242 minutos (04h02min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 57,3%. A distribuição do sono registrado mostrou 26,9% de estágio 1, 46,3% de estágio 2, 17,4% de estágio 3 e 9,5% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 166,5 minutos em vigília, ocorreram 137 microdespertares (índice: 34/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 66,2/hora, sendo 34,7 apneia/hora e 31,5 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 66,2/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 94%, sendo a média de 91% e a mínima de 66%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono

TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (66,2/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (66,2/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 56; máxima: 73 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de baixo a médio.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 13 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (124 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 57,3%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 34/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante cíclico (PAC) durante o estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (26,9%; normal: 8-10%) e 3 (17,4%; normal: 10-12%), e a redução do estágio REM (9,5%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 2 (46,3%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros.

Sem contrações masseterinas.

Escala de Sonolência de Epworth: 6 (normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: ANDRÉ LUIZ ROSA MAYORAL	Peso: 85 Kg	Altura: 1,85 m
Sexo: M	Idade: 53 anos	Exame: 30281_01
IMC: 24,8	Data do Exame: 17/05/2013	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 22:25:50 horas e encerrado às 06:41:03 horas, com latência para o sono de 5 minutos e latência para o sono REM de 27 minutos. O tempo total de sono foi de 385,0 minutos, com eficiência do sono de 77,7%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	11,6%	Até 5%
Estágio 2	50,5%	45 - 55%
Estágio 3	20,0%	> 15%
Sono REM	17,9%	20 - 25%
Eficiência do sono	77,7%	> 85%

No período total de sono permaneceu 110,5 minutos acordado e ocorreram 88 micro despertares (índice de 13,7 /hora).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 61 bpm, a maior de 69 bpm e a menor de 54 bpm.

Foram identificados 0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora.

Ocorreram 76 eventos respiratórios, sendo 0 central, 76 obstrutivos e 0 misto. O índice de apnéia/hipopnéia total foi 11,8/hora, sendo 1,7 apnéia/hora e 10,1 hipopnéia/hora. O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 13,0/hora, sendo 1,7 apnéia/hora e 11,3 hipopnéia/hora.

A saturação basal da oxihemoglobina foi de 93%, sendo a saturação média de 93%, a maior de 98% e a mínima de 82%, permanecendo 8,1 minutos (1,6%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,0 minutos (0,0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 69 dessaturações.

Resumo dos resultados

- 1 - Paciente com Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau leve, sendo todos os eventos do tipo obstrutivo (normal até 5/hora).
- 2 - Presença de dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Registro de ronco.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono diminuída devido ao tempo total desperto durante o exame (normal > 85%).
- 6 - Porcentagem normal do sono de ondas lentas e diminuída do sono REM.
- 7 - Latência diminuída do sono REM.
- 8 - Não foram identificados movimentos periódicos de membros inferiores.

José Alexandre Addeo Cipolli
CRM-SP 104110